HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

L'aide-soignant à l'accueil - Rôle & missions

Mr Giovanni SILVETTI

IDE Référent – Service des urgences

Dr Mehdi LAFI

Médecin & Chef adjoint – Service des urgences

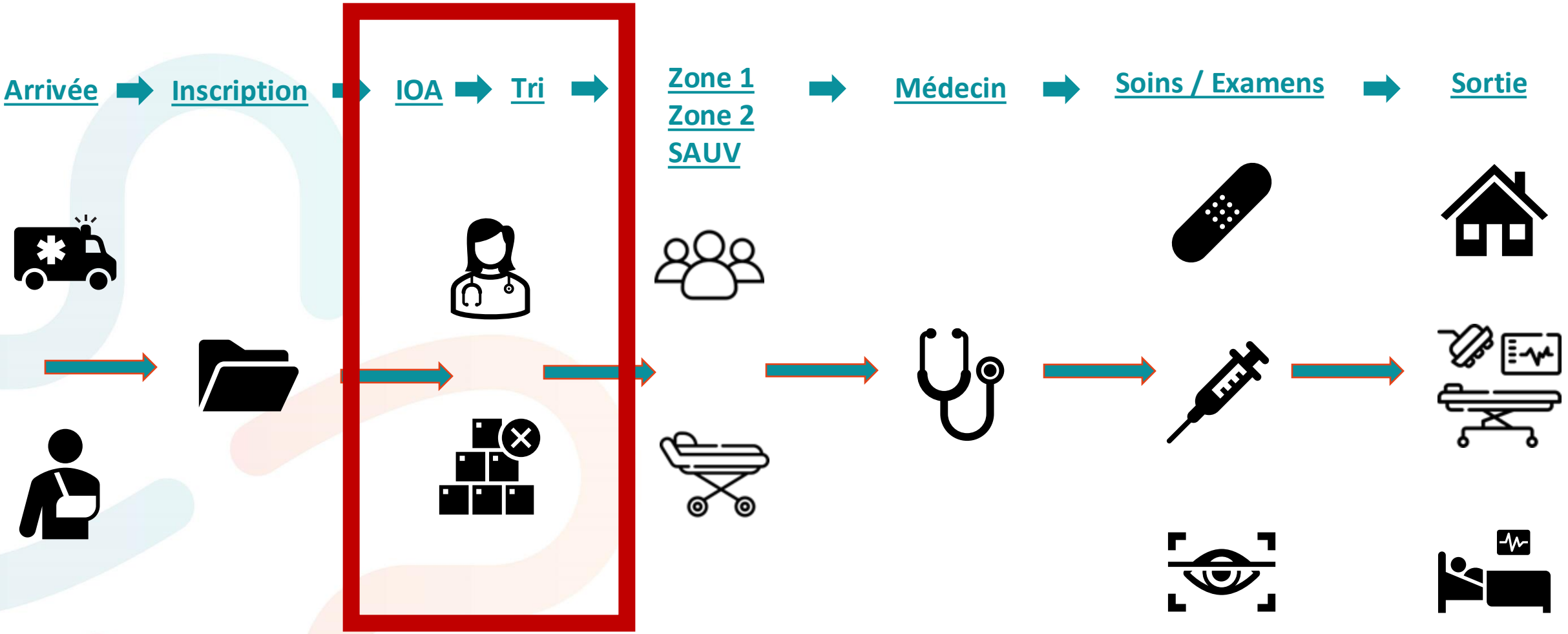
Date

Sommaire

1. Rôle et missions
2. Rappels
1. Protocole/Procédures

1. ROLE ET MISSIONS AS

Parcours patients aux urgences



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier d'orientation et d'accueil, mes missions.

La mission générale de l'IOA définie dans le référentiel de la SFMU est d' « *Accueillir de façon personnalisée le patient et ses accompagnants à leur arrivée, définir les priorités de soins en fonction des besoins exprimés et/ou constatés, et, en fonction de ces derniers, décider du lieu de soins adapté. Ces actions ont pour objectif d'améliorer la qualité de prise en charge des patients et de leurs accompagnants dès l'accueil. Elles sont menées en lien constant avec le médecin référent chargé de superviser le fonctionnement du service et la gestion des flux.* »

1. **Accueillir, évaluer et procéder à un tri des patients arrivant aux urgences**
2. **Décider du lieu de soins adapté**
3. **Installer**
4. **Informer, aider, rassurer**
5. **Surveiller**
6. **Anticiper**
7. **Communiquer et coordonner**
8. **Enseigner**

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l’accueil, mes missions.

Le rôle de l'AS à l'IOA est d'accueillir de façon "personnalisée" le patient et ses accompagnants à leur arrivée. L'AS, sous la responsabilité et en collaboration avec l'IDE IOA vont définir les priorités de soins en fonction des besoins exprimés et/ou constatés.

7 Missions

1. Accueillir
2. Installer
3. Informer, aider, rassurer
4. Surveiller
5. Anticiper
6. Communiquer et coordonner
7. Enseigner

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l'accueil, mes missions.

Accueillir des patients arrivant aux urgences

1

L'IOA accueille = soin relationnel auprès du patient.

- Objectif : permettre de comprendre et d'accepter les soins dans les meilleures conditions :
  - gestion du stress, information, écoute, installation, confort, prise en charge de la douleur

IOA : 4 étapes

1 Accueil

Présentation (prénom, fonction, intérêt de l'évaluation, variation ordre de passage : temps d'attente environ)

Â **information indispensable** = acceptation de l'attente + diminution de l'anxiété.

= Soins relationnel, relation de confiance.

2 Analyse

Examen clinique infirmier :

Examen physique (5 sens – Ø goût).

- Vue
- Toucher
- Odorat
- Ouïe

3 Entretien

Entretien : 3Q2C

- Qui ?
- Quoi ?
- Quand ?
- Comment ?
- Combien ?

Paramètres vitaux :

- FC
- TA
- SpO2
- FR
- Température
- Douleur

4 Décision

Décision du niveau de tri & choix de la zone de soins en fonction des éléments recueilli et des critères de gravité ou non du patient

→ Grille de tri

IDE

Accueillir *Évaluer* *Tri*

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

La grille ST-JO

ROUGE

Patient présentant une détresse ou pathologie nécessitant installation immédiate

CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
- ACR
- Tas < 80mmHg et/ou Signes périphériques de choc (marbrures - cyanose des extrémités)
- FC > 140 ou FC < 45
- Douleur thoracique avec modification ECG
- TAS > 220mmHg symptomatique
- Patient présentant un QSofa > ou = 2 critères.

RESPIRATOIRE
- FR < 10
- SpO2 < 94% sous 6L/min d'O2 ET FR > 22
- Hémoptysie active ou hémoptysie avec SAT < 94%
- Détresse respiratoire haute (laryngée) ou CE avec hyper sialorrhée

NEUROLOGIQUE
- Coma avec score de Glasgow < 9
- **Déficit neurologique < 4h30 (même si constaté au réveil)**

DIGESTIF
- Hémorragie digestive active : hématémèse – méléna – rectorragies très abondantes (avec défaillance hémodynamique)

INFECTIOLOGIE
- Hypothermie avec **modification ECG**

INTOXICATION quelle que soit la nature
- **Avec modification ECG**

MÉTABOLIQUE
- Hyperglycémie (dextro = HI) avec cétonémie > 1,5
- Hypoglycémie avec dextro ≤ 0.3
- Hyperkaliémie > 6 mmol/L avec modification ECG
- Hypokaliémie < 2,5 même sans modification ECG

TRAUMATOLOGIE
- Amputation de membre complète ou quasi complète (sauf doigts et orteils)
- Plaie artérielle évidente/ou garrot mis en place
- Brûlures : étendues (> 10% SC) et/ou circulaire AVEC antalgie par anesthésie vigile ou siège particulier : ORL – tête – périnée
- Traumatisme pénétrant (arme blanche ou arme à feu) du thorax ou abdomen ou crânien ou cervical
- Electrisation ou électrocution avec modification ECG après accord du MAO

PÉDIATRIE : SAU sans activité pédiatrique
- ACR
- Coma

ORANGE

Patient alité présentant une constante d'alerte ou une pathologie potentiellement grave et/ou urgente

CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
- Syncope sans prodromes *(À SCOPER)*
- Association de 2 critères suivants : *(À SCOPER)*
  - PAS ≤ 100 mmHg
  - Polypnée ≥ à 22/min
  - Trouble des fonctions supérieures (confusion, désorientation, Glasgow < 15)
- Douleur thoracique typique persistante sans trouble de la repolarisation à l'ECG *(À SCOPER)*
- TAS > 220mmHg non symptomatique

RESPIRATOIRE
- FR > 30/min *(À SCOPER hors crise d'angoisse)*
- Ou Signes de lutte respiratoire *(À SCOPER)*

NEUROLOGIQUE
- Troubles de la conscience avec score de Glasgow 9 - 14
- > 2 crises épilepsie dans l'heure (non épileptique connu) *(À SCOPER)*

INFECTIOLOGIE
- Hyperthermie > 39°C

INTOXICATION quelle que soit la nature
- Glasgow < 15 et > 9

MÉTABOLIQUE
- Hypoglycémie avec score de Glasgow de 14 ou 15
- Hyperkaliémie > 6 mmol/L sans modification ECG

TRAUMATOLOGIE
- Brûlures : étendues (> 10% SC) SANS antalgie par anesthésie vigile ou SANS siège particulier : ORL – tête – périnée (non circulaire)
- Plaie du scalp de grande taille très hémorragique **après accord du MAO**

DOULEUR
- EN > 7 pour titration en morphine → Avec transmissions orales (IDE/MEDECIN)
- EN entre 5 et 7 nécessitant la prise d'Oxynorm

JAUNE

Patient alité mais ne présentant ni signe de gravité, ni d'urgence

ROSE

Fast Track Zone non valide

- Rétention aigue d'urine
- **Déficit neurologique constitué ou transitoire de + de 6h et – de 24h.**
- Mono traumatisme de membre hors tronc
- Traumatisme **bassin/hanche** de la personne âgée
- **TC sans signe** de focalisation de la personne non valide **(pas de prise d'anticoagulant)**.
- Patient adressé pour réalisation d'un Angioscanner devant des **Ddimères** augmentés.
- Crise convulsive résolutive d'un patient **épileptique connu**
- Anémie **sans autres anomalies** (paramètres vitaux stable + pas de saignement extériorisé)
- Mauvaise évolution d'un **ulcère suivi au GHPSJ**
- Colique néphrétique hyperalgique
- Ebriété sur la voie publique, **Glasgow 14 et/ou somnolent mais réveillable**,
- IMV du sujet non délirant, **Glasgow 15 (non agité et sans ATCD psychiatrique).**
- Epistaxis **non traumatique** avec stabilité hémodynamique
- Douleur abdominale du sujet de **moins de 30 ans, sans ATCD,** nécessitant d'être couché.
- Douleur thoracique atypique du sujet de **moins de 30 ans, sans ATCD,** nécessitant d'être couché.
- **FTPA (seulement si correspond aux critères suivants) :**
  - **+ de 75 ans, sans problème sociaux**
  - **Motif de consultation simple et aigu (<7 jours) et/ou chutes à répétitions.**

VIOLET

Patient valide présentant un des motifs suivants :

- Crise d'asthme
- Eruption cutanée supposée allergique récente et évolutive
- Douleur des organes génitaux externe (OGE).
- Patient arrivant pour un problème psychiatrique (sans problème somatique) ou **CPU psychiatrique**.
- Patient arrivant avec un diagnostic chirurgical **avéré**
- Patient adressé des urgences gynécologiques
- Patient reconvoqué par les urgences nécessitant des examens complémentaires (bilan sang, imagerie, un avis spécialisé ou une hospitalisation)

BLEU

Patient valide ne présentant ni signes de gravité, ni d'urgence

- Plaies
- Trauma des extrémités avec fracture ou signes cliniques de fracture (déformation)
- Patient nécessitant un bilan sang et/ou un examen d'imagerie (TDM, Echo)
- Patient nécessitant un avis spécialisé

VERT

Patient valide (avec un objectif de qualité institutionnelle de prise en charge ≤ à 1h30)

- Traumatisme simple des extrémités (non fracturé) avec prescription de radios anticipées
- AES
- CNA
- Panaris collecté isolé
- Consultation simple ne pouvant être réorientée
- Patient reconvoqué (par les urgences) pour une simple consultation/ordonnance

MARRON

Consultation Post-urgences (CPU) de Psychiatrie

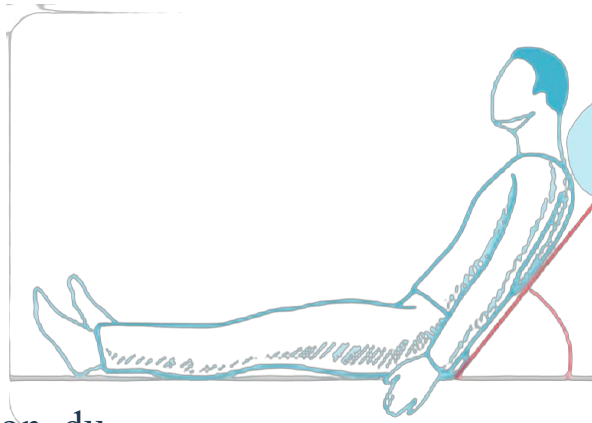
Patient arrivant pour un problème psychiatrique (sans problème somatique et sans besoin d'évaluation somatique a priori)

HOPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l'accueil, mes missions.

2

Installer



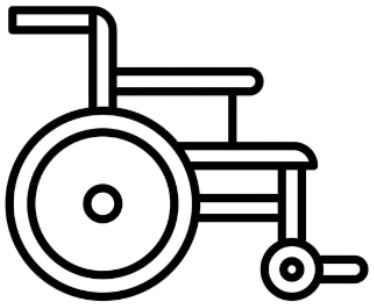
L'IOA installe ou fait installer le patient en fonction de ses besoins

<u>Attention certaines installations doivent être respecté en fonction du motif IOA :</u>

- Tout patient avec problème respiratoire (dyspnée) avec ou sans O2 : position demi-assise.
- Tout patient présentant un signe neurologique, évoquant un probable AVC : position allongée stricte.



TOUS LES PATIENTS DOIVENT ETRE DESHABILLER A L'IOA OU DANS LE BOX EN ZONE 2
DESHABILLAGE = HAUT ET BAS





HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l’accueil, mes missions.

Informer, aider, rassurer

3

L’AS informe le patient et ses accompagnants de l'organisation des soins, du fonctionnement du service, du délai et des raisons d'une attente éventuelle.

L'AS rassure les familles et les informe des soins en cours et à venir, de l’attente des examens de laboratoire et/ou d’imagerie.

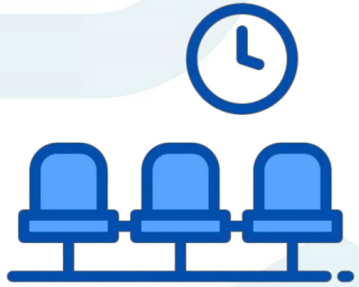
L’AS est en relation permanente avec les médecins et infirmier(e)s effectuant les soins des différentes zones.

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l’accueil, mes missions.

Informer, aider, rassurer

3

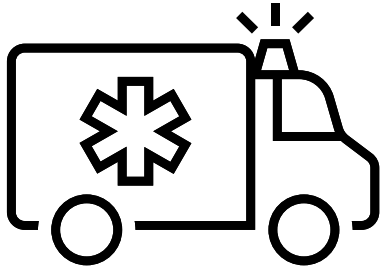












HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Accompagnant

SAU

IOA

Zone Valide

Zone Couchée

SAUV

*

*

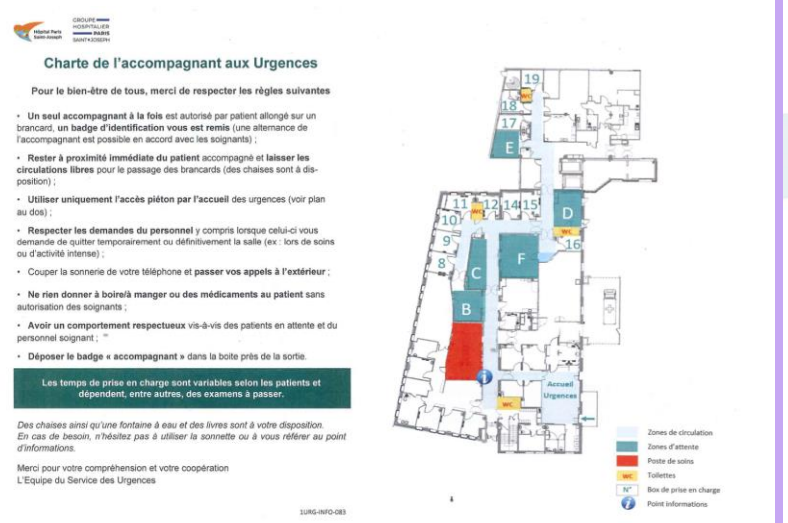
Lits d'urgences

2 Accompagnants / patient

Charte

Badge

Flyer



Charte de l'accompagnant aux Urgences

Pour le bien-être de tous, merci de respecter les règles suivantes

- **Un seul accompagnant à la fois** est autorisé par patient allongé sur un brancard, **un badge d'identification vous est remis** (une alternance de l'accompagnant est possible en accord avec les soignants) ;
- **Rester à proximité immédiate du patient** accompagné et **laisser les circulations libres** pour le passage des brancards (des chaises sont à disposition) ;
- **Utiliser uniquement l'accès piéton par l'accueil** des urgences (voir plan au dos) ;
- **Respecter les demandes du personnel** y compris lorsque celui-ci vous demande de quitter temporairement ou définitivement la salle (ex : lors de soins ou d'activité intense) ;
- Couper la sonnerie de votre téléphone et **passer vos appels à l'extérieur** ;
- **Ne rien donner à boire/à manger ou des médicaments au patient** sans autorisation des soignants ;
- **Avoir un comportement respectueux** vis-à-vis des patients en attente et du personnel soignant ; "
- **Déposer le badge « accompagnant »** dans la boite près de la sortie.

Les temps de prise en charge sont variables selon les patients et dépendent, entre autres, des examens à passer.

Des chaises ainsi qu'une fontaine à eau et des livres sont à votre disposition. En cas de besoin, n'hésitez pas à utiliser la sonnette ou à vous référer au point d'informations.

Merci pour votre compréhension et votre coopération
L'Equipe du Service des Urgences

1URG-INFO-083

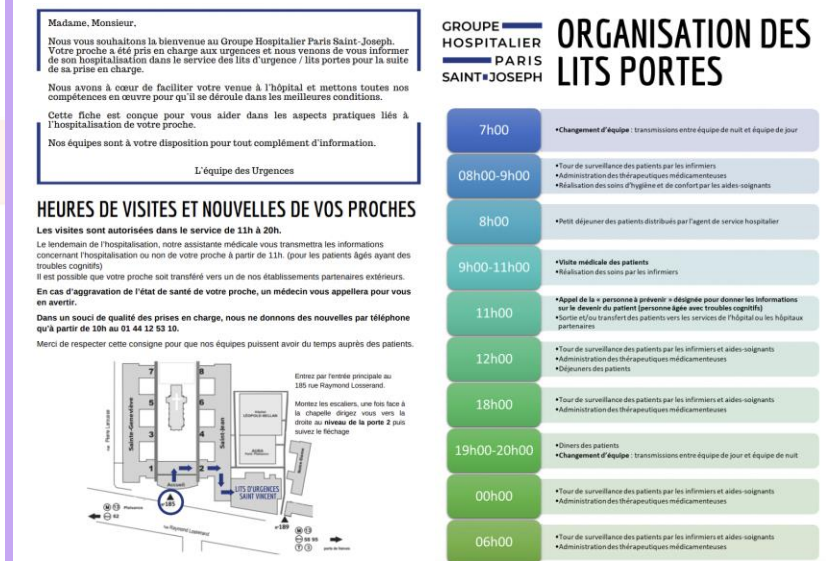
Hôpital Paris Saint-Joseph
GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

ACCOMPAGNANT

Service des urgences

En cas de "fin de vie", il n'y a pas de restrictions.

**Selon l'appréciation du soignant*



Madame, Monsieur,

Nous vous souhaitons la bienvenue au Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph. Votre proche a été pris en charge aux urgences et nous venons de vous informer de son hospitalisation dans le service des lits d'urgence / lits portes pour la suite de sa prise en charge.

Nous avons à cœur de faciliter votre venue à l'hôpital et mettons toutes nos compétences en œuvre pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions.

Cette fiche est conçue pour vous aider dans les aspects pratiques liés à l'hospitalisation de votre proche.

Nos équipes sont à votre disposition pour tout complément d'information.

L'équipe des Urgences

HEURES DE VISITES ET NOUVELLES DE VOS PROCHES

Les visites sont autorisées dans le service de 11h à 20h.

Le lendemain de l'hospitalisation, notre assistante médicale vous transmettra les informations concernant l'hospitalisation ou non de votre proche à partir de 11h. (pour les patients âgés ayant des troubles cognitifs)
Il est possible que votre proche soit transféré vers un de nos établissements partenaires extérieurs.

En cas d'aggravation de l'état de santé de votre proche, un médecin vous appellera pour vous en avertir.

Dans un souci de qualité des prises en charge, nous ne donnons des nouvelles par téléphone qu'à partir de 10h au 01 44 12 53 10.

Merci de respecter cette consigne pour que nos équipes puissent avoir du temps auprès des patients.

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

ORGANISATION DES LITS PORTES

7h00	•**Changement d'équipe** : transmissions entre équipe de nuit et équipe de jour
08h00-9h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers •Administration des thérapeutiques médicamenteuses •Réalisation des soins d'hygiène et de confort par les aides-soignants
8h00	•Petit déjeuner des patients distribués par l'agent de service hospitalier
9h00-11h00	•**Visite médicale des patients** •Réalisation des soins par les infirmiers
11h00	•**Appel de la « personne à prévenir » désignée pour donner les informations sur le devenir du patient (personne âgée avec troubles cognitifs)** •Sortie et/ou transfert des patients vers les services de l'hôpital ou les hôpitaux partenaires
12h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers et aides-soignants •Administration des thérapeutiques médicamenteuses •Déjeuners des patients
18h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers et aides-soignants •Administration des thérapeutiques médicamenteuses
19h00-20h00	•Diners des patients •**Changement d'équipe** : transmissions entre équipe de jour et équipe de nuit
00h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers et aides-soignants •Administration des thérapeutiques médicamenteuses
06h00	•Tour de surveillance des patients par les infirmiers et aides-soignants •Administration des thérapeutiques médicamenteuses

Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l’accueil, mes missions.

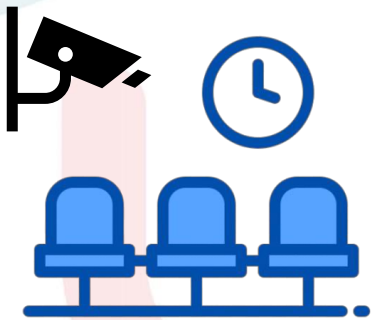
4

Surveiller

L’AS assure la surveillance régulière de la salle d’attente, coordonne les informations destinées aux accompagnants et aux familles, apaise au mieux les tensions afin de prévenir toutes formes de violences.

L’AS est amené(e) à surveiller les salles d’attentes des patients en attente de prise en charge médicale.

L’AS peut intervenir à tout moment dans les salles d’attentes.





HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l’accueil, mes missions.

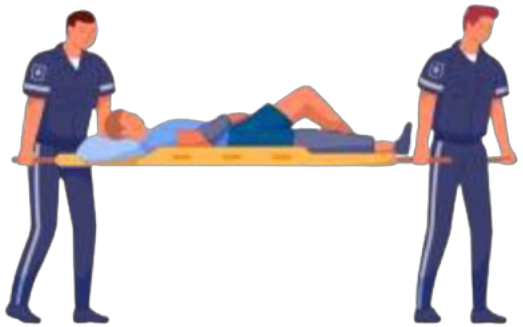
Anticiper

5

L’AS sera capable d'évaluer la gestion du flux. Elle reconnaitra également les urgences vitales à priorisé, en collaboration avec les IOA et les AMA.







HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l'accueil, mes missions.



Règles IOA

Délai d'attente avant IOA ne devant pas excéder **30** minutes

IOA ne devant pas excéder **5/10** minutes

Au-delà de **30** minutes ET/OU **5** patients en attente

=

IOA 3

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l'accueil, mes missions.

Communiquer ET coordonner

6

Pour favoriser une bonne communication et essayer d'apaiser au mieux les craintes et/ou angoisses des accompagnants, l'AS comme l'IOA centralise les informations, localise les patients afin de pouvoir répondre à toute demande.

Les familles doivent, par sa présence et ses informations, trouver un(e) interlocuteur(trice) référent(e) performant(e).



MAO	IOA 1	IOA 2	IDE Z2A	IDE Z2B	AS Z2A	AS Z2B
78.63	61.90	61.91	73.37	83.29	73.97	61.59

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Aide-soignant à l’accueil, mes missions.

Enseigner

7

Dans le contexte spécifique de l’accueil et du tri dans un service d’urgences,

L’AS encadre les étudiants infirmiers et étudiants aides-soignants en stage.

Elle accompagne également les infirmier(e)s en période de formation.



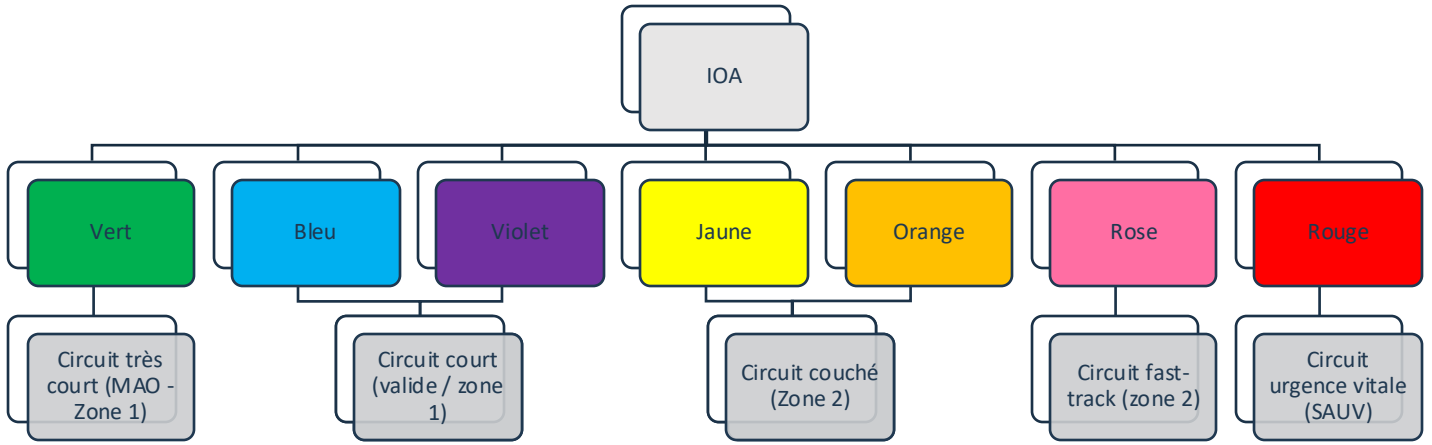
HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

LE 3Q2C

Outil permettant de réaliser l'interrogatoire clinique

QUI	Age, Sexe, ATCD, épisodes similaires, TTT Spécifiques
QUOI	Motif (attention peut être différent à l'arrivée)
QUAND	Date et heure de début
COMMENT	Facteurs déclenchants, circonstances, mode de début et d'évolution
COMBIEN	Intensité du symptômes, pics, évolution

Le tri IOA



Zone Valide = Zone 1

Violet : Prise en charge immédiate
Bleu : Prise en charge médicale dans l'heure
Vert : circuit particulier – PEC 1H30 début/fin.



Zone couchée = Zone 2

Orange : Prise en charge médicale < 60 min
Jaune : Prise en charge médicale < 90 min
Rose : Fast Track (prise en médicale < 60 min + PEC dans le service < 2h)



SAUV

Rouge : Prise en charge médicale immédiate



GRILLE DE TRI

ROUGE
Patient présentant une détresse ou pathologie nécessitant installation immédiate
CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
ACR
Tas < 80mmHg et/ou Signes périphériques de choc (marbrures - cyanose des extrémités)
FC > 140 avec ECG et après avis MAO ou FC < 45
Douleur thoracique avec modification ECG
TAS > 220mmHg symptomatique
Patient présentant un **QSofa > ou = 2 critères.**
RESPIRATOIRE
FR < 8
SpO2 < 94% sous 6L/min d'O2 ET FR > 22
Hémoptysie active ou hémoptysie avec SAT < 94%
Détresse respiratoire haute (laryngée) ou CE avec hyper sialorrhée
NEUROLOGIQUE
Coma avec score de Glasgow < 9
Déficit neurologique < 4h30 (même si constaté au réveil)
DIGESTIF
Hémorragie digestive active : hématémèse – méléna – rectorragies très abondantes (avec défaillance hémodynamique)
INFECTIOLOGIE
Hypothermie avec **modification ECG**
INTOXICATION *quelle que soit la nature*
Avec modification ECG
MÉTABOLIQUE
Hyperglycémie (dextro = HI) avec cétonémie > 1,5 **OU** Hypoglycémie avec dextro ≤ 0.3
Hyperkaliémie > 6 mmol/L avec modification ECG **OU** Hypokaliémie < 2,5 même sans modification ECG
TRAUMATOLOGIE
Amputation de membre complète ou quasi complète (sauf doigts et orteils)
Plaie artérielle évidente/ou garrot mis en place
Brûlures : étendues (> 10% SC) et/ou circulaire AVEC antalgie par anesthésie vigile ou siège particulier : ORL / tête / périnée
Traumatisme pénétrant (arme blanche ou arme à feu) du thorax ou abdomen ou crânien ou cervical
Electrisation ou électrocution avec modification ECG après accord du MAO
PÉDIATRIE : SAU sans activité pédiatrique
ACR / Coma

SAUV

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

GRILLE DE TRI

ORANGE
Patient alité présentant une constante d'alerte ou une pathologie potentiellement grave et/ou urgente
CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
Syncope sans prodromes *(À SCOPER)*
Douleur thoracique typique persistante sans trouble de la repolarisation à l'ECG *(À SCOPER)*
RESPIRATOIRE
SpO2 < 94% sous O2 < 6L/min ET FR > 22 *(À SCOPER)*
NEUROLOGIQUE
Troubles de la conscience avec score de Glasgow 9 – 14
> 2 crises épilepsie dans l'heure (non épileptique connu) *(À SCOPER)*
INTOXICATION *quelle que soit la nature*
Glasgow < 15 et > 9
MÉTABOLIQUE
Hypoglycémie avec score de Glasgow de 14 ou 15
Hyperkaliémie > 6 mmol/L *(À SCOPER)*
TRAUMATOLOGIE
Brûlures : étendues (> 10% SC) SANS antalgie par anesthésie vigile ou SANS siège particulier : ORL – tête – périnée (non circulaire)
Plaie du scalp de grande taille très hémorragique **après accord du MAO**
DOULEUR
EN > 7 pour titration en morphine → Avec transmissions orales (IDE/MEDECIN)
EN entre 5 et 7 nécessitant la prise d'Oxynorm

Zone 2A* ou *Zone 2B

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

GRILLE DE TRI

JAUNE
Patient alité mais ne présentant ni signe de gravité, ni d'urgence

Zone 2A ou Zone 2B

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

GRILLE DE TRI

ROSE
Patient stable sur le plan hémodynamique, monomotif, nécessitant d'être allongé
Rétention aigue d'urine
Douleur de la fosses lombaires hyperalgiques non fébrile (hors 1er épisode + de 60 ans).
Douleur des OGE de plus de 24h, non brutale.
Déficit neurologique (moteur, sensitif, sensoriel ou du langage) + de 6h et – de 24h (Appel IDE Zone 2B)
Problème de matériel médical
Mono traumatisme de membre hors tronc
Traumatisme **bassin/hanche** ne pouvant pas être en zone valide.
TC sans signe de focalisation de la personne non valide **(pas de prise d'anticoagulant).**
Patient adressé pour réalisation d'un Angioscanner devant des **Ddimères augmentés.**
Crise convulsive résolutive d'un patient **épileptique connu**
Anémie sans autres anomalies (paramètres vitaux stable + pas de saignement extériorisé)
Erythème et/ou œdème d'un membre isolé, hors anaphylaxie.
Plaie non traumatique (ulcères MI, escarres hors stade IV).
Plaie superficielle hors main, ou zones à risque du visage.
Ebriété sur la voie publique, **Glasgow 14 et/ou somnolent mais réveillable.**
IMV du sujet non délirant, **Glasgow 15 (non agité et sans ATCD psychiatrique).**
Epistaxis **non traumatique** avec stabilité hémodynamique
Douleur abdominale isolée du sujet de moins de 50 ans, sans ATCD ou comorbidité.
Douleur thoracique atypique du sujet de moins de 50 ans, sans ATCD ou comorbidité.
Douleur articulaire, de membre, sciatique et ou rachidienne sans fièvre.
HTA non symptomatique (suppression dans le tri orange de TAS > 22 mmHg asymptomatique)
Membre chaud, douloureux, OMI.
FTPA (seulement si correspond aux critères suivants) :
+ de 75 ans, sans problème sociaux
Motif de consultation simple et aigu (<7 jours) et/ou chutes à répétitions.

Zone 2B

Si Zone 2B fermées, le tri rose va en zone 2

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

GRILLE DE TRI

VIOLET
Patient valide présentant un des motifs suivants :
Crise d'asthme Eruption cutanée supposée allergique récente et évolutive Douleur des organes génitaux externe (OGE). Patient arrivant pour un **problème psychiatrique (sans problème somatique) ou CPU psychiatrique.** Patient arrivant avec un **diagnostic chirurgical avéré** Patient adressé des **urgences gynécologiques** Patient reconvoqué par les urgences nécessitant des examens complémentaires (bilan sang, imagerie, un avis spécialisé ou une hospitalisation) **Patient(e) victime de violences conjugales (installation en box)**

Zone 1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

GRILLE DE TRI

BLEU
Patient valide ne présentant ni signes de gravité, ni d'urgence
Plaies Trauma des extrémités avec fracture ou signes cliniques de fracture (déformation) Patient nécessitant un bilan sang et/ou un examen d'imagerie (TDM, Echo)

Zone 1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

GRILLE DE TRI

MARRON
Consultation Post-urgences (CPU) de Psychiatrie Patient arrivant pour un problème psychiatrique (sans problème somatique et sans besoin d'évaluation somatique a priori)

Zone 1

TRI ULTRA PARTICULIER

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

GRILLE DE TRI

VERT
Traumatisme simple des extrémités (non fracturé) avec prescription de radios anticipées
AES
CNA
Panaris collecté isolé
Consultation simple ne pouvant être réorientée

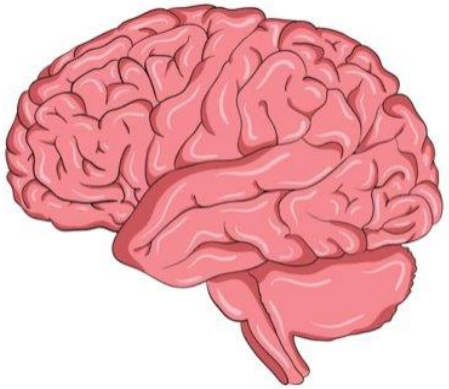
Zone 1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

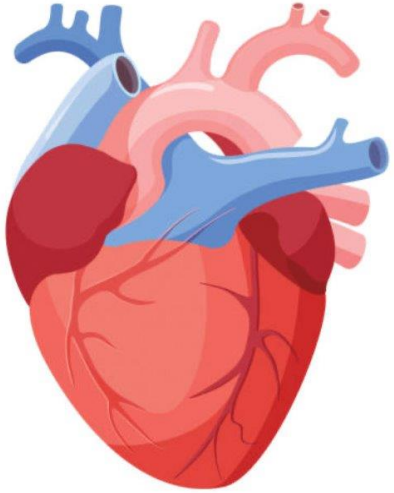
2. Rappels

LES PRINCIPALES DETRESSE

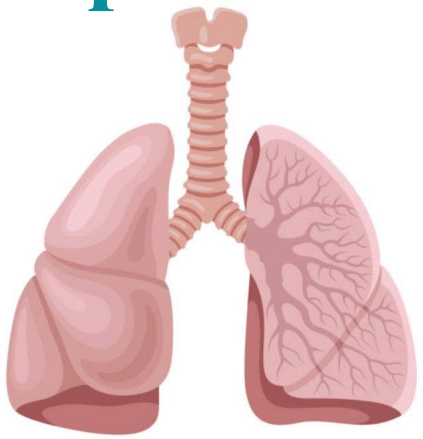
Neurologique



Circulatoire

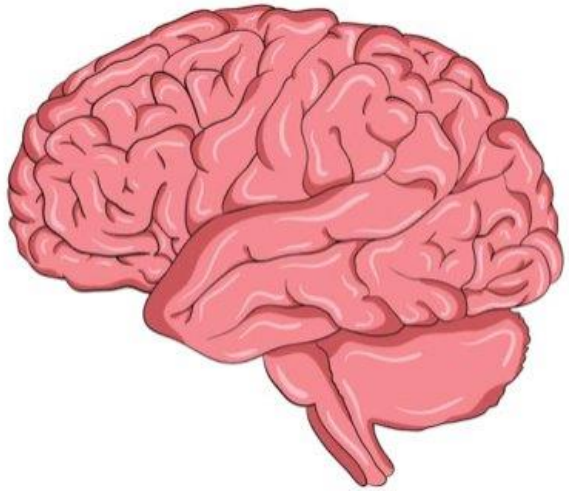


Respiratoire



HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Neurologique



Conscience / Vigilance
Comportement
Déficit

Déficit neurologique :

1 : Moteur
2 : Sensitif
3 : Langage

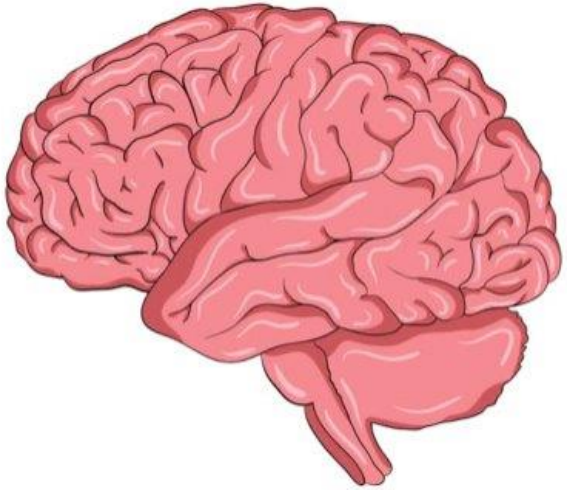
Paramètres vitaux :

Glasgow
Etat de conscience (trouble cognitif)

⚠ Confusion sans déficit = pas d'AVC / AIT

Neurologique

Comment les reconnaitre :



- Trouble de la CONSCIENCE (vigilance : COMA)
- Troubles du COMPORTEMENT (Sd confusionnel : DTS, Rupture avec état antérieure, Varie
- DEFICITS neurologiques (moteur, sensitif, visuel, parole …) → penser au sens

- = Détresses neurologiques

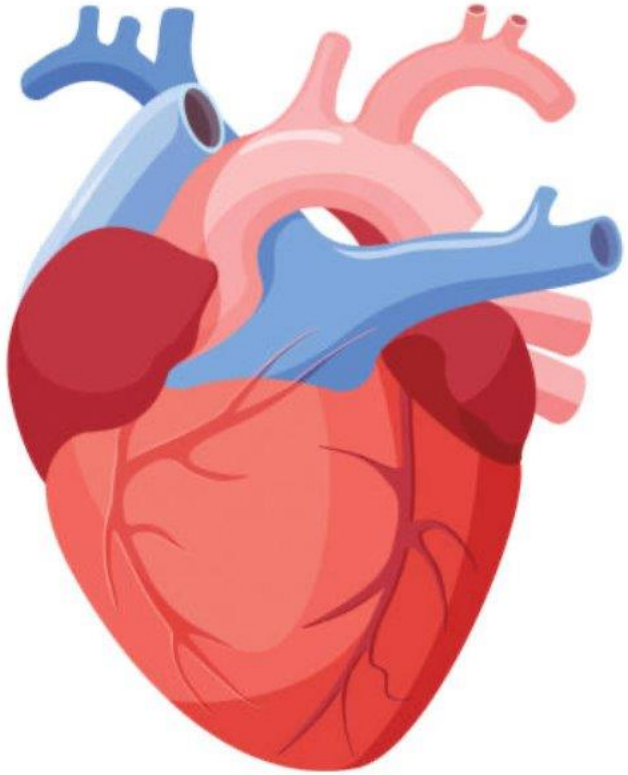
Les déficits neurologiques

Paralysie / Equilibre / Vision / Parole / Mal de tête

Attention à la confusion isolée

- Cause somatique : RAU / Fécalome / Prise de toxiques

Circulatoire



Paramètres vitaux :

Fréquence cardiaque

Tension artérielle

Clinique :

Perfusion systémique

Perfusion systémique :

Peau : TRC / marbrures

Cerveau : baisse de la vigilance / sd confusionnel / coma

Rein : Oligo-anurie

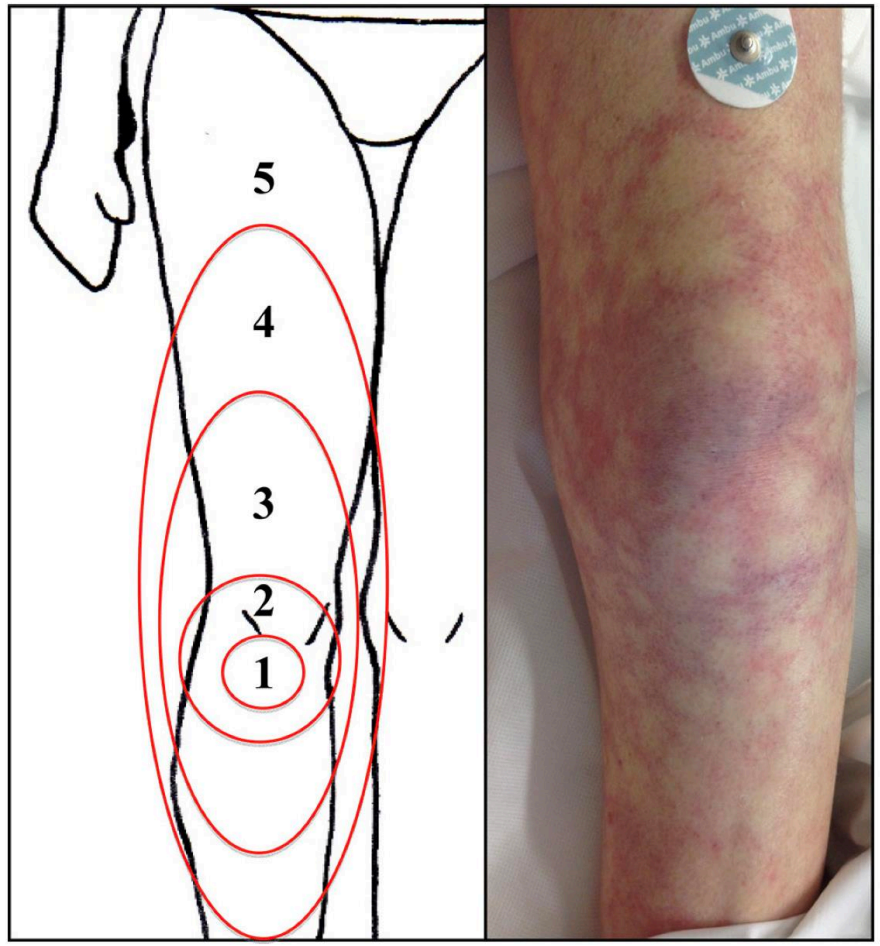
HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

En rapport à la circulation

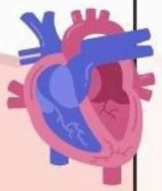
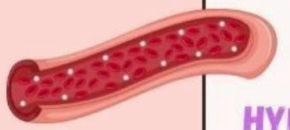
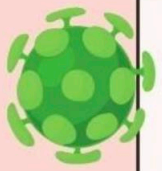
Traînées violacées des téguments

› Au niveau des genoux
› Au niveau des flancs à un stade plus tardif, voire généralisées

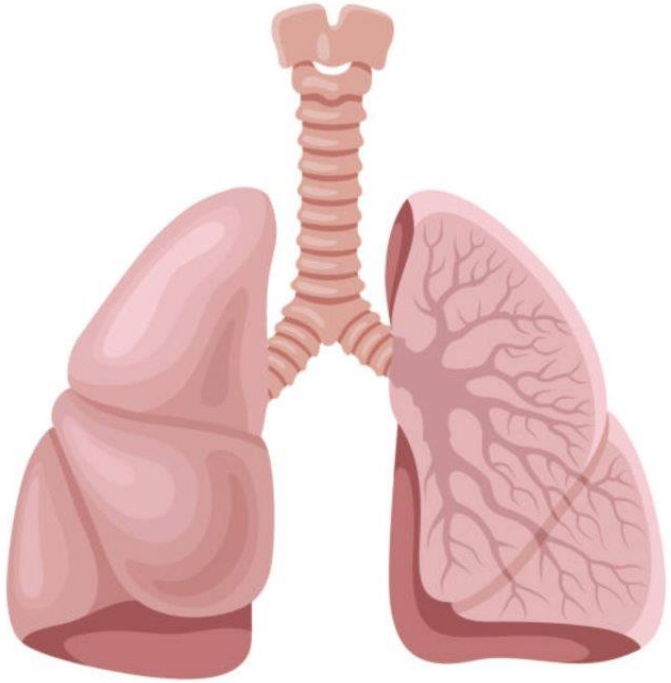
Secondaires à une diminution du débit sanguin provoquant une vasoconstriction des vaisseaux cutanés.



En rapport à la circulation

 **CHOC CARDIOGÉNIQUE**	Le coeur n'arrive pas à pomper assez de sang pour assurer les besoins de perfusion de l'organisme
 **CHOC HYPOVOLÉMIQUE**	Hypovolémique ↙ ↓ ↘ "Faible" "Volume" "dans le sang" Diminution du volume intra-vasculaire
 **CHOC SEPTIQUE**	Causé par une infection étendue d'une bactérie ou d'un virus
 **CHOC ANAPHYLACTIQUE**	Réaction allergique sévère
 **CHOC NEUROGÉNIQUE**	Vasodilatation de durée étendue à cause d'un déséquilibre entre les systèmes sympathique et parasympathique

Respiratoire



Paramètres vitaux :

Saturation en oxygène (SpO2)

Fréquence respiratoire

⚠ Pas de SpO2 **SANS** Fréquence respiratoire

Clinique :

Travail respiratoire

Battement des ailes du nez (nourrisson)

Balancement thoraco-abdo

Muscles intercostaux (tirage intercostal)

Hypoxie (désaturation)

Cyanose ; Tachycardie ; Trouble neurologiques

Hypercapnie

Sueurs ; Somnolence ; Troubles neurologiques

Autres rappels anatomo-physiologique

L'ictère

Coloration jaune ou jaunâtre de la peau et/ou du fond d'œil

Appelé couramment « jaunisse »

→Examen physique +++

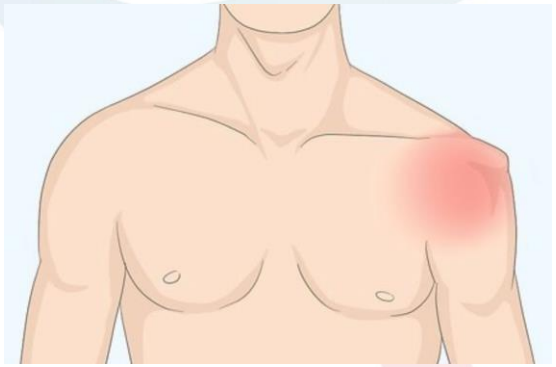


Traumatismes

Observation +++

Déformation +/-

Luxation = signe de l'épaulette



Dermatologies

➢ Erysipèle



➢ Purpura



➢ Fasciite



➢ Fasciite nécrosante



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

L’IOA et la pédiatrie









L'IOA et la pédiatrie



- Evaluer la conscience
- Déshabiller *(si nécessaire)*
- Evaluer l'A/B/C *(+ entretien, + P.V)*
- Peser le patient, si nécessaire *(non réalisable à St-Jo, mais demander aux parents si enfants à perdu du poids).*

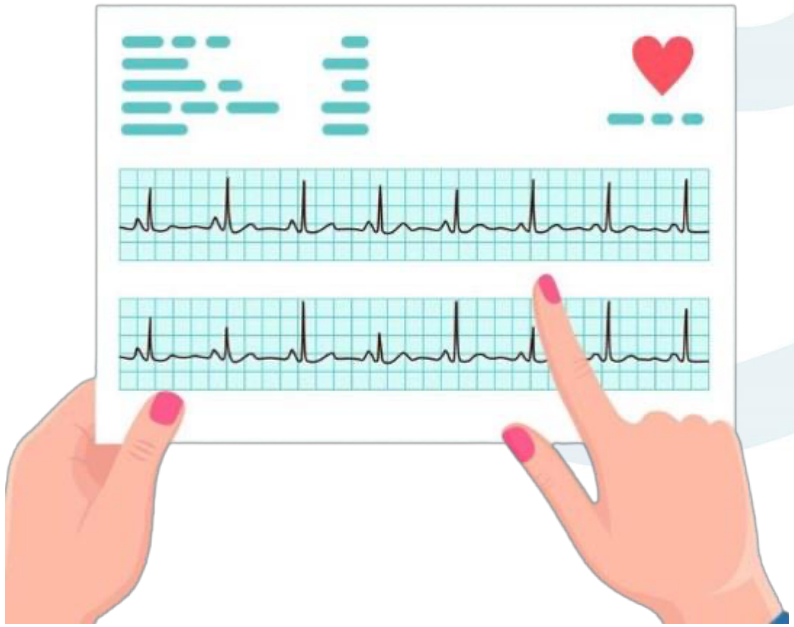
- **Entretien avec les parents essentiellement et rassurer**

HYPOXIE = 1er cause d'ACR chez l'enfant (ou hypoxémie)

› **A : Airways :** Voie aérienne libres ou à risque *(N.N à 6 ans : respiration nasale seulement).*
› **B : Breathing :** Fréquence ; Travail : signes de lutte ; Volume : amplitude ; Oxygénation : SpO2.
› **C : Circulation :** FC ; TA ; Perfusion périphérique : TRC.

3. Protocoles / procédures

Protocole demande anticipée de bilan radiologique



DOULEUR THORACIQUE / EPIGASTRIQUE

DOULEUR DORSALE (OMOPLATE)

DOULEUR EPAULE GAUCHE (SANS TRAUMA)

MALAISE

ANOMALIE BILAN SANGUIN :

- **HYPER / HYPOKALIEMIE**
- **TROPONINE AUGMENTEE**

HYPOTHERMIE

FREQUENCE CARDIAQUE < 45 ou > 120

ANEMIE < 10g/dL HB + ATCD : IDM / STENT / PONTAGE

IMV

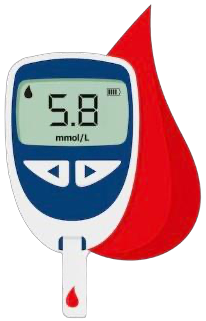
TRAUMA THORACIQUE (nécessitant d'être allongé)

SI INSTALLATION A LA SAUV → PAS D'ECG A L'IOA

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Dextro / Cétonémie

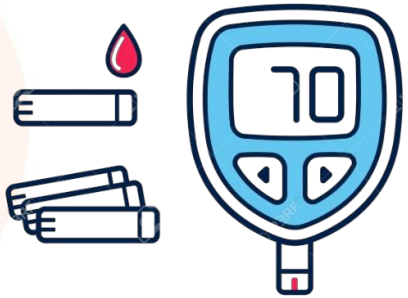
DEXTRO (HGT) POUR



- VERTIGES
- VOMISSEMENTS
- MALAISE
- DIABETIQUE
- CONVULSIONS
- TROUBLE NEUROLOGIQUES
- TRAUMATISME CRÂNIEN
- TROUBLES DU COMPORTEMENT

HGT > 3g

CETONEMIE

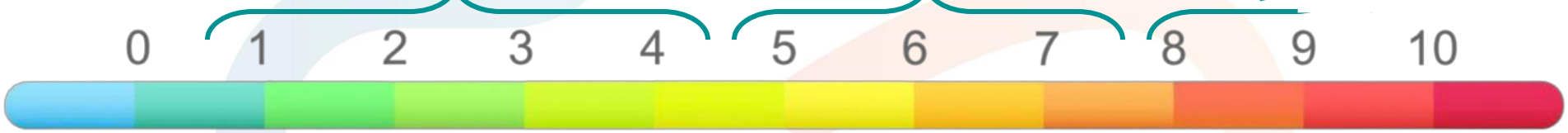


HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Douleur

EVALUATION
EN (1er intention)
Algoplus® (sujets âgés, non communicants)
EVS, si EN impossible

MOYEN NON MEDICAMENTEUX (immobilisation, glaçage)



DOLIPRANE ORO®
500MG x 2

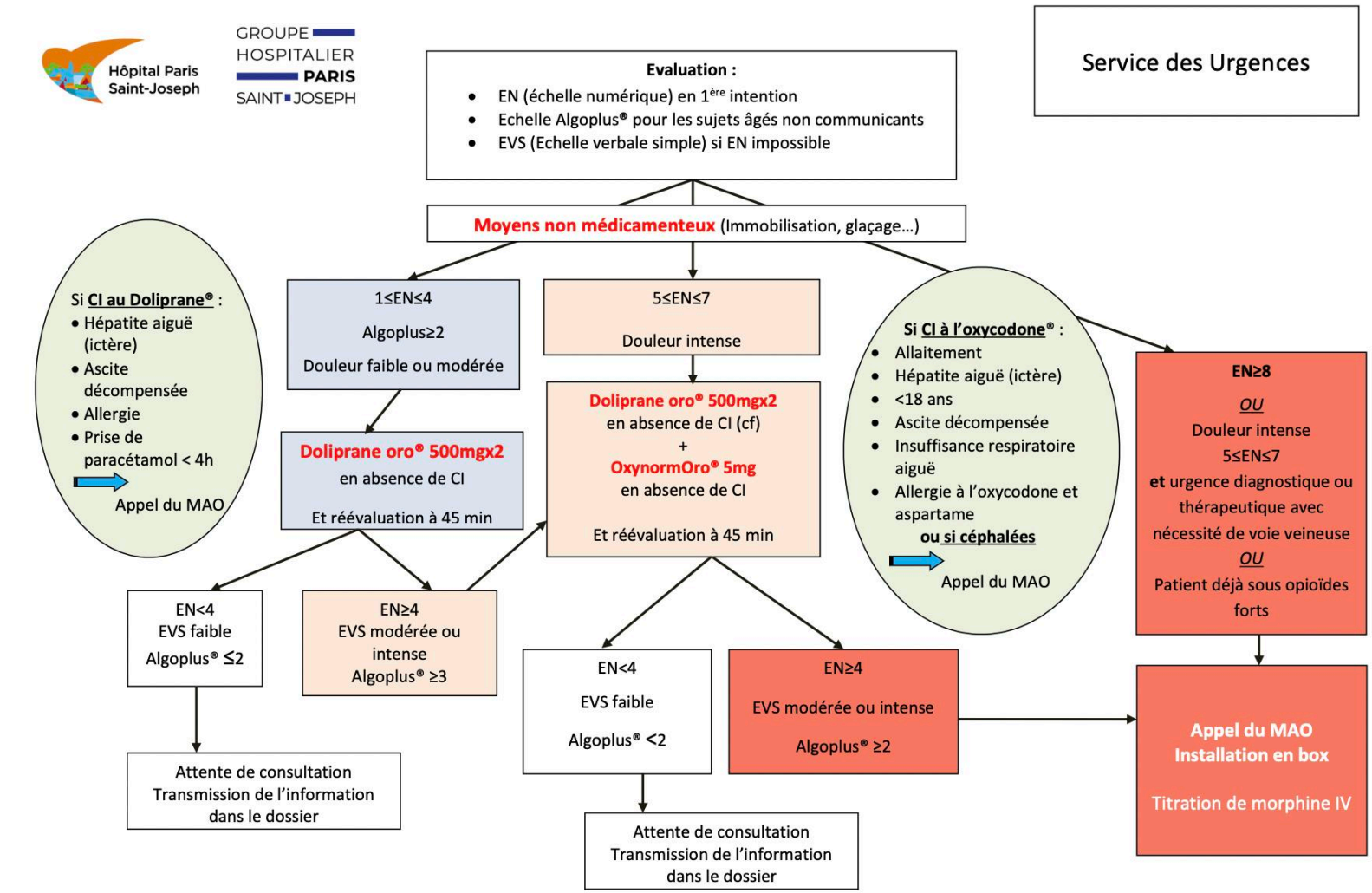
DOLIPRANE ORO®
500MG x 2
+
ACTISKENAN ORO®
10MG

DOLIPRANE ORO®
500MG x 2
+
ACTISKENAN ORO®
10MG
ET / OU
TITRATION MORPHINE IV

REEVALUATION A 45MIN

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Douleur



HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Précautions / BMR / BHRe

Ouvrir le dossier du patient, ou regarder dans la liste si isolement

RAPPEL

BMR

BLSE **SARM**

Précautions complémentaires contact

Installation possible dans les espaces d'attentes (B, C, D, E, F).

BHRe

EPC **ERV**

Précautions complémentaires contact renforcées

Installation en box uniquement de l'entrée à la sortie du service



+ de 3 mois à l'étranger (DOM-TOM compris)

Hospitalisation ou soins à l'étranger

Dépistage BMR + BHRe

Dépistage **BLSE** + **SARM** et **EPC** + **ERV**

QUEL ECOUVILLON



BLSE
EPC
ERV

Dépistage rectal



SARM

Dépistage nasal

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Mineur

- Patient mineur entre 16 et 18 ans
- Doivent être accompagné d'un majeur obligatoirement
- Isolement en box
- Autorisation de soins signé obligatoirement par les parents + scanner dans le dossier dès l'IOA.
  Si parents non présents, prévenir encadrement + demandé aux parents d'envoyer un mail donnant l'autorisation de soins.
  Je soussigne ….

CNA

- Demander le motif de la consultation à la police

- Si patient calme et coopérant, demander à la police de patienter en dehors du box
  - Â Secret professionnel.
  - Â Police à chaque porte IOA + Agent de sécurité à la porte vitrée

- Après évaluation → Appel MAO pour prévenir du CNA + Isolement en box (ou installation box MAO ou IOA 3)

- Si patient présente un risque pour le soignant, autorisation qu'un agent de police vous accompagne dans le box.
  Pas de question portant au secret professionnel.

Fugue / Sortie à l'insu du service

- Attention à la différence : 2 procédures différentes.

- Fugue = Danger pour le patient
  - Remplir la fiche fugue dans le recueil soignant
    - Prévenir Encadrement
      - Transmission dans le dossier patient + FEI

- Sortie à l'insu du service = Pas de danger pour le patient
  - Remplir la fiche sortie à l'insu du service dans le recueil soignant

Si vous constatez une disparition (voir avec médecin pour statuer si fugue ou sortie).
Prévenir agent de sécurité SAU + recherche dans le service.
Appel du patient sur son numéro de téléphone.
Prévenir sécurité de l'hôpital